

## 07 - 08- Présentation de siège (Audio) - Pr. Soummani

Donc, qu'est-ce que c'est la présentation du siège ? C'est l'inverse de la présentation céphalique. La présentation céphalique, je parle de présentation céphalique, et non pas de présentation du sommet. Vous connaissez ça.

La présentation du sommet, c'est lorsque la tête est bien fléchie. La présentation céphalique, c'est toutes les présentations de la tête. Je vais vous faire la prochaine fois les présentations céphaliques des fléchies, c'est-à-dire les autres présentations céphaliques que le sommet, que vous avez fait, je pense, avec Harold.

Donc, la présentation du siège, c'est lorsque le bébé se présente au détroit supérieur par les fesses, tout simplement. Donc, la tête, c'est en haut, et le siège, c'est en bas, le siège avec les pieds et les membres inférieurs. Donc, c'est une présentation, c'est l'extrémité pelvienne qui se présente en premier au détroit supérieur.

Ce n'est pas une présentation dystoïque. Les vraies présentations dystoïques sont de deux. Vous pouvez les écrire comme ça.

Deux. Deux présentations qui sont dystoïques, c'est-à-dire qui sont incompatibles avec l'accouchement normal. Tu fais le diagnostic, il faut faire une césarie.

La présentation du front ou la présentation de l'épaule. Donc, c'est les deux présentations qui sont dystoïques. Le reste, c'est des présentations eutoïques, mais avec des conditions.

Pour le sommet, vous avez vu les conditions. Si tu as un bip au-delà de 11 centimètres, 110, c'est un macrozone, il ne peut pas. Mais à poids normal, une présentation du sommet, c'est une présentation eutoïque.

La présentation du siège, également, c'est une présentation eutoïque. C'est-à-dire que le bébé peut naître par voie naturelle. Lorsque je dis présentation eutoïque, c'est-à-dire la césarienne n'est pas systématique.

Lorsque je dis présentation dystoïque, ça veut dire que la césarienne est systématique. Dès que tu fais le diagnostic, tu dois faire la césarienne. Ici, dans la présentation du siège, la présentation est eutoïque.

Mais, toujours le « mais » de la médecine, c'est une présentation eutoïque à la limite de la dystoïe, c'est-à-dire n'importe quel accident au cours de la couche, quel incident au cours de l'accouchement, va rendre la présentation dystoïque. Et il faut faire une césarienne. C'est pour ça qu'elle est appelée présentation eutoïque, elle est qualifiée de présentation eutoïque à la limite de la dystoïe.

De la dystoïe, mais c'est la dystoïe. Qu'est-ce que c'est l'accouchement à rebrousse-poil ? Vous

connaissez ce que c'est que la rebousse-poil ? Message à la tête. C'est ça.

C'est ça ? Cette dérègle, c'est l'accouchement à rebousse-poil. Donc l'accouchement à imaginer et ça va être très facile. Lorsque tu as une présentation du sommet, l'accouchement se fait comme ça.

Par contre lorsque c'est le siège, l'accouchement se fait comme ça. Donc ça c'est l'accouchement Bon il y a beaucoup de complications, c'est pas comme dans la présentation du sommet, beaucoup de complications, que ce soit les complications maternelles, en général c'est les déchirures du périnée, les et cetera, le taux élevé de césarien, le taux élevé de césarien c'est une complication. Normalement il ne faut pas avoir beaucoup, un taux élevé de césarien.

Au privé ils sont à égale à 50%, mais apparemment c'est jusqu'à 60% de césarien. Et ça c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que tu fais la première césarienne, la deuxième césarienne, troisième accouchement, ça va être un placenta accreta.

Placenta accreta c'est le placenta qui va pénétrer dans la cicatrice. Dans le myomètre. Donc il ne va pas, la délivrance ne va pas se faire.

Par conséquent il risque de faire une hémorragie de la délivrance. Et ça en France il y a une augmentation très importante des hémorragies de la délivrance à cause des césariennes. Mais on n'est pas responsable à 100%.

Il y a également la société qui est responsable. Parce qu'actuellement les femmes sont des femmes actives, sont des femmes qui travaillent, sont des femmes qui ne veulent pas plus de deux grossesses, maximum trois grossesses. Et la grossesse doit aboutir à un nouveau-né.

On n'a pas le droit de perdre un nouveau-né. C'est pour ça l'ostétricien a peur. Bon, il fait la césarienne pour avoir un bébé de bonne santé.

Est-ce qu'il a tort ou il a raison? Il a peur des poursuites judiciaires. Et puis la césarienne est plus simple. Tu fais entrer la femme au bloc, une demi-heure après tu sors, la césarienne est faite et tout va bien.

Par contre l'accouchement c'est tout un travail qui peut durer jusqu'à 12, 14 heures et tu dois être présent à l'accouchement. Donc vous voyez, moins de poursuites judiciaires, plus et moins de travail. Mais il faut dire qu'actuellement, aux États-Unis, il y a des bureaux, vous savez les bureaux des avocats, c'est des bureaux.

Il y en a à de la il y a les avocates et un dom de spécialité. L'architecture. des lignes pour la césarienne.

Une césarienne c'est-à-dire il n'y avait pas d'indication C'est vrai on m'a poursuivi, ça ne veut pas dire comme nous euh la prison c'est le civile. l'assurance et cetera. Mais attention l'année

prochaine les assurances vous voyez c'est compliqué mais vous allez apprendre ça après c'est une présentation et par conséquent la césarienne n'est pas systématique n'est pas systématique ça veut dire que c'est pas n'importe quelle femme enceinte avec une présentation de siège je vais lui faire une césarienne non il y a des conditions il y a des indications pour faire la césarienne il y a des indications pour laisser l'accouchement se faire et je suis là à n'importe quel moment je peux arrêter lorsque ça devient dangereux je peux arrêter l'accouchement et je fais une césarienne donc lorsque je dis que l'accouchement par voie basse est possible est possible c'est-à-dire je laisse un moment X ça peut se transformer en césarienne c'est la césarienne systématique et la césarienne secondaire la césarienne systématique c'est lorsque je fais le diagnostic c'est une césarienne avant même le travail par contre la césarienne différé c'est-à-dire je donne la chance à la femme d'accoucher par voie basse je la surveille et en fonction de la surveillance je vais décider de laisser évoluer l'accouchement jusqu'à le travail jusqu'à l'accouchement ou bien il me paraît qu'il y a des problèmes au cours du travail j'arrête le travail et je fais la césarienne donc voilà un peu de quoi il s'agit donc la fréquence il faut dire que c'est une présentation qui n'est pas très fréquente 3% la présentation du sommet 95% c'est le sommet 3% c'est le siège les 2% restants c'est les autres la face Bregma le front l'épaule donc c'est 3% mais elle est plus fréquente la présentation du siège est plus fréquente chez le prématuré vous allez me dire pourquoi pourquoi le prématuré pour la simple raison que est-ce que vous connaissez la culbite physiologique de pageau la culbite physiologique c'est quoi en général au cours de la grossesse c'est normalement le bébé l'évolution du bébé au début il y a la tête qui est grosse et le tronc c'est trop petit comme l'évolution de l'embryon jusqu'au fœtus etc donc la tête est plus grand est plus grande que le tronc au cours de l'évolution la tête va diminuer de volume et le tronc va augmenter de volume à 34 semaines la tête devient petit et le tronc devient plus gros et l'évolution du fœtus la loi d'accommodation c'est quoi la loi d'accommodation dit que le l'extrémité le plus volumineux va aller occuper la place la plus vaste au niveau de l'utérus on sait que le fond de l'utérus c'est plus grand qu'au niveau de du segment inférieur donc la tête et le tronc le tronc à 34 semaines le tronc devient plus grand donc il y a une rotation physiologique qui est mécanique physique où la tête va passer en bas et le tronc va passer en haut ça s'appelle la culbite physiologique ou là la rotation physiologique l'ébriété il se fait aux alentours de 34-35 semaines lorsqu'on a un prématuré à 33 semaines 32 semaines c'est toujours la tête qui est plus grosse donc il est toujours il n'a pas encore subi la rotation physiologique c'est pour ça la prématurité est une cause de c'est pas une cause mais elle est plus fréquente le siège est plus fréquent en cas de prématurité est-ce que vous avez compris? Donc voilà c'est c'est plus fréquent chez le prématuré dû à au fait qu'il y a une absence de la loi d'accommodation de le le l'extrémité le plus c'est un obstétricien la manoeuvre s'appelle la manoeuvre de poiseau il ne faisait que l'obstétrique donc ça c'est la fréquence les étiologies les étiologies vous allez voir que les présentations qu'on appelle les présentations irrégulières les présentations irrégulières c'est toutes les présentations en dehors de de de la présentation du sommet les autres colombes présentation irrégulière des étiologiques, les étiologies s'écoulent toujours il y a les causes maternelles, les causes fœtales, les causes ovulaires cause maternelle, les causes fœtales, les

causes ovulaires les causes ovulaires donc on a les causes ovulaires les causes fœtales qui ont en rapport avec le fœtus et les causes maternelles qui ont en hypoplasie, il n'a pas l'espace pour laisser la rotation, donc l'hypoplasie de l'utérus, les malformations utérines, s'il y a une cloison ou un utérus bicorné, c'est la même chose, la même explication, et il y a les anomalies congénitales de la hanche, surtout sur la chirurgie traumatologique, la luxation congénitale de la hanche, elle est pourvoyeuse de plus de présentations de sièges que le reste, si vous me demandez pourquoi, je ne sais pas, c'est des statistiques, comme quoi la femme qui a une luxation congénitale de la hanche fait plus de présentations de sièges, bon les causes acquises, toutes les causes acquises, un fibrome utérin, un kyste de l'eau verte, la multiparité, parce que l'utérus devient vaste, trop vaste, donc il continue à faire ses rotations jusqu'au travail, lorsque le travail commence, le fœtus va prendre une présentation, il y a également les anomalies, la primiparité c'est comme l'utérus hypoplasique, c'est l'utérus qui est hypertonique, qui est très contracté et il fait la même chose, et il y a les anomalies acquises du bassin, à savoir les plus fréquentes, c'est les fractures de la cavité cotyloïde, les fractures cotyloïdes, l'enfoncement acétabulaire, je pense l'enfoncement acétabulaire, les traumatologues, le temps est la même chose, donc voilà les causes maternelles, les causes ovulaires, anomalies du liquide amniotique, soit en excès ou en défaut, c'est-à-dire s'il y a une oligoamniose, il n'y a pas de liquide, donc l'enfant ne peut pas tourner, s'il y a une hydroamniose, il y a beaucoup de liquide et l'enfant va continuer à tourner jusqu'au moment de l'accouchement, donc c'est les deux.

Donc les anomalies du liquide amniotique, la brièveté du cordon, lorsque le cordon est trop court, le cordon, le placenta, le cran, le membrane d'or, le cordon qui est fixé ici, il va empêcher le fœtus de tourner. L'abréviation de cordon est une anomalie et l'insertion anormale du placenta. Le placenta va insérer, comme le fibro, il va empêcher la rotation.

Les causes fœtales, la prématurité, je vous ai dit ça, les malformations fœtales. Par exemple, le plus souvent, l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, en général, elle se présente en sièges.

La grosse hydrocéphalie. Donc, l'hydrocéphalie, les malformations fœtales, la grossesse multiple également, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Voilà les idéologies de la présentation du siège.

Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. C'est très bien. Donc, voilà, vous êtes intéressés par le diagnostic.

Le diagnostic, actuellement, est devenu très facile. C'est une femme qui va venir. Donc, vous allez faire l'interrogatoire en PC.

Donc, déroulement de la grossesse actuelle, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et après, vous allez faire votre inspection, votre examen clinique ou l'examen océtrical. C'est la même chose.

Examen clinique, examen océtrical. L'inspection, c'est une présentation qui est longitudinale. Donc, le utérus est longitudinal.

Il n'est pas comme la présentation de l'épaule où il est transversal. Dès l'inspection, vous allez voir ça. Mais c'est la même chose que le sommet.

Même le sommet de l'utérus est longitudinal. À la palpation, on parlait d'eux. Ça, ça devient intéressant.

Parce que la présentation du sommet, vous allez palper la tête au niveau du pelvis et le siège qui est mou, qui est irrégulier au niveau du fond de l'utérus. Ici, vous allez trouver l'inverse. Vous allez trouver une extrémité qui est solide, qui est régulière, qui balote entre les mains au niveau du fond, et le siège qui est irrégulier, qui est mou au niveau en bas.

Mais ça, ça nécessite surtout que la femme ne soit pas obèse. Il n'y a pas beaucoup de poids. C'est-à-dire une femme, l'angélique.

Ici, c'est une femme qui a pris du poids. C'est difficile de trouver ça. C'est tout simplement ça.

Vous allez aller chercher le plan du dos parce que tu as la tête, tu as le cou, le sillon du cou, et tu as la colonne ici. En général, le plan du dos, c'est là où vous allez ausculter pour voir les bruits du corps. En général, les bruits du coeur foetal, la présentation du sommet, c'est au-dessous de l'ombilique.

Le siège, c'est au-dessus de l'ombilique. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est pertinent. En général, on met notre stéthoscope de Pinard et on cherche où se trouve le foyer des bruits du coeur.

Ce n'est pas obligatoire. Mais en général, si vous avez un sommet, vous cherchez au-dessous de l'ombilique. Si vous avez un siège, vous cherchez au-dessus de l'ombilique.

Ce qui est important dans la présentation du siège, c'est que tu as la tête, tu as le dos, mais tu n'as pas, parce qu'il est comme ça, le fœtus, tu n'as pas un sillon entre la tête et il n'y a pas de dépression entre la tête et la colonne vertébrale, et le dos, donc il n'y a pas de sillon, il n'y a pas de dépression ici, parce qu'il est en hyperflexion. En général, il est en hyperflexion. Vous allez voir qu'il y a des cas où il y a une déflexion.

L'auscultation, c'est péri- ou sous-ombilical. Le toucher vaginal, vous faites votre toucher vaginal, en général, le col est fermé, parce que la femme n'est pas au travail, et puis l'excavation est vide, parce que le siège est haut situé. Ce n'est pas comme la tête.

La tête, en général, on le touche. Même s'il est haut situé, on arrive à toucher. Ici, c'est très difficile de trouver la présentation.

Ce n'est pas grave, parce que vous pouvez vous aider des examens complémentaires, qui sont l'échographie et ou la radio de contenu utérin. Tout simplement, il y a un squelette. Vous allez

voir la tête qui est en haut et le siège en bas.

La radio. L'échographie, la même chose. Vous allez trouver la tête haut située et le siège en bas.

L'échographie va vous donner plus, parce que vous allez mesurer le biparietal, vous allez mesurer la longueur de fémur, vous allez mesurer la circonférence abdominale, vous allez voir s'il y a de liquide amniotique, vous allez voir l'insertion du placenta, est-ce qu'elle est bien insérée ou non, ainsi de suite. Ça, c'est au cours du travail. Non, ça, c'est au cours de la grossesse, en dehors du travail.

Le col est fermé et la présentation est haute. Au cours du travail. L'inspection, c'est la même chose.

La palpation, c'est la même chose. Le toucher vaginal. Le toucher vaginal va vous donner plus de précision.

Mais ça dépend de l'état de la poche des os. On essaie la poche des os d'ailleurs. Si la poche des os n'est pas rompue, il ne faut pas vous acharner à trouver la présentation parce que vous allez rompre la poche des os avant.

Alors qu'il faut préserver au maximum la poche des os intacte. Je vous expliquerai pourquoi on utilise la mécanique obstétrique. Mais si la poche des os est rompue, le diagnostic devient plus facile parce que vous allez faire votre diagnostic, les fesses, l'anus, le sillon interfécié et le sacrum.

Le sacrum. Le sacrum qui est le repère de la présentation. Donc, la poche des os est intacte, il faut la respecter.

La présentation est molle. C'est les fesses. Il n'y a pas de structure osseuse.

Pas de sillon interosseux, pas de bregma ou lambda ou de Shimakeus. Lorsque la poche des os est rompue et que vous allez faire la présentation, vous allez voir que dans la présentation du siège, il y en a plusieurs, mais il y en a deux modes de présentation. Il y a la présentation décomplétée.

Il y a la présentation, le siège décomplété et le siège complet. Le siège décomplété, c'est lorsque les deux membres inférieurs sont en expansion devant le tronc. Il n'y a qu'à nous, les membres, parce qu'ils bougent de l'avant pour qu'on appuie sur l'autre.

Il n'y a qu'à nous, les membres, en expansion, qui fait le toucher, qui va trouver le siège, mais qui ne va pas trouver de pieds. Parce qu'ils sont devant pratiquement. Par contre, dans le siège complet, même les pieds sont en bas, les entailleurs.

Donc, vous allez trouver tout ça, mais devant, vous allez trouver les petits pieds du bébé. Ça,

c'est le mode de la présentation, mode complet, siège complet et siège décomplété. Il n'y a pas les intermédiaires.

Voilà, le siège décomplété, vous allez trouver les deux masses qui sont les fesses, et puis vous allez trouver le sillon interfessier. Il n'y a pas de pieds. Dans le siège complet, vous allez toucher les pieds du bébé.

Bien sûr, je vous ai dit que vous allez trouver le sacrome, qui est le repère de la présentation. Le sommet chinois, c'est le repère de la présentation. Non, l'occipite.

Le repère de la présentation est l'occipite. Le repère de la présentation du siège, c'est le sacrome. Le repère de la présentation du front, c'est le nez.

Le repère de la présentation de la face, c'est le montant. C'est ce que vous devez savoir. Je ne vais pas vous expliquer les autres.

Dans les deux tableaux, le repère, le siège, le sacrome, le sommet, l'occipite, la face, le montant, le front, le nez. Le bregma, c'est le front, mais le bregma, en général, comme le front, c'est pratiquement, on ne fait que des césariens parce qu'ils donnent beaucoup de traumatisme. Donc, vous allez trouver le sacrome.

S'il est en haut, à droite ou à gauche, ou là en bas, à droite ou à gauche, ça va vous définir les variétés. Sacro, il y a gauche antérieure. Sacro, il y a droite antérieure.

Sacro, il y a gauche antérieure. Donc, c'est comme l'occipite, il y a gauche. Vous pouvez le voir.

La même chose. Je vais vous dire comment il y a le support du schéma. On va voir si les poteaux sont bons.

Si les poteaux ne sont pas bons, on va leur donner le support du schéma. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, c'est bon.

Ah, ah. Bon. Non.

Donc, ils ne sont pas là. Ils sont quelque part. Bon, ce n'est pas grave.

Et en fait, le monde de la présentation Le monde de la présentation, c'est quoi? le monde. Bon, je ne suis pas fan de mais je vais essayer Madame en bonhomme, en présentation du siège, dans le siège décomplété, vous allez trouver les deux, c'est comme ça. Vous voyez, c'est peut-être ce qu'il y a, ça c'est le mode, le siège décomplété.

Par contre, le siège complet, c'est ça, il fait ça, il fait ça. Donc ça, c'est le siège décomplété et ça, c'est le siège complet, c'est-à-dire toute l'extrémité inférieure est en bas. Dans le siège décomplété, parce que c'est un siège décomplété complet, tous les éléments du siège sont en bas, le siège et les membres internes.

Par contre, le siège décomplété, il n'y a plus de siège, les membres internes. Mais attention, il n'y en a pas que ça. C'est un petit bébé, un petit croque-marte, quoi, quoi.

Vous pouvez trouver ça, par exemple. Vous pouvez trouver un bébé comme ça. Oui, c'est là que ça existe.

Et c'est mauvais, ce n'est pas un bon premier siège. Vous pouvez trouver un autre comme ça. Par contre, c'est pas si difficile.

Et là, pour les membres du siège, ça devient plus difficile. Ici, en fait, bon, ça, c'est la surface cubienne. Elle est là.

Ici, c'est le sacrum. Et ici, c'est le dos. C'est joli.

Et là, là, c'est un bassin. Quand vous allez trouver, le sacrum va être là, ou bien il va être là, ou bien il va être là, ou bien il va être là. Comme vous avez réfléchi, le sacrum, s'il est en haut, il est enterré.

S'il est en bas, il est postéré. S'il est de l'autre côté, il n'y en a pas, dire comme ça. C'est gauche pour elle.

Oui, et si c'est gauche, c'est droit pour elle. Il n'y en a pas d'autre. Donc, ça, vous définissez, vous allez définir sacro, agréablement, sacroilière, gauche supplémentairement, antérieure.

Sacro, ilière, gauche, antérieure. Révis, sacro, ilière, droite, postérieure. Révis, sacro, ilière, droite, antérieure.

Révis, sacro, ilière, gauche, postérieure. La plus fréquente, il y a. Pourquoi? Ça, elle nous dit que c'est ça, mais c'est plutôt ilière, gauche, antérieure. C'est la plus fréquente.

Pourquoi c'est la plus fréquente? Pourquoi par hasard? Rien n'est lié au hasard floccitique, la mécanique. C'est pour ça qu'elle est appelée mécanique. C'est des éléments physiques.

Tout simplement, crétio le bassin. Au cétricale. Et crétio.

Qui est un oblique droit et un oblique gauche. Je vous dis que l'oblique gauche est toujours supérieur d'un demi-centimètre par rapport à l'oblique droit. Non? Un douze, un douze-virgule-cinq.

Le gauche, douze-virgule-cinq. Le droit, douze. Vous allez me dire pourquoi.

La femme est normale. Ce n'est pas une anomalie du bassin. Il y a une différence d'un demi-centimètre entre les deux obliques chez une femme normale.



Vous allez me dire pourquoi. Je vais vous dire. On est des bipodes.

Je suis droitier. J'ai tendance à m'appuyer sur le membre inférieur droit plus que le membre inférieur gauche. Et pour le gaucher, c'est l'inverse.

Oui. Oui, le problème. Le problème, c'est que lorsque j'étais jeune, j'avais les os qui sont encore mous, il y a des cartilages, etc.

Il y a une tendance à l'enfoncement de la cavité cotyloïdienne en dedans, à l'intérieur du bassin. Ce qui fait que pour moi, le droit est plus petit que le gauche. Pour le gaucher, c'est l'inverse.

C'est l'oblique droit qui est plus grand que l'oblique gauche. C'est ça. Pourquoi un oblique est plus grand que l'autre.

C'est un problème réel du membre. Désolé pour la traduction. Donc c'est OK pour les modes de présentation, c'est OK pour les variétés.

Les variétés sont importantes. Les modes, c'est important pour le pronostic. Mais les variétés, elles sont importantes pour la conduite obstétricale.

Parce que toutes les variétés postérieures font plus de temps pour l'accouchement que les variétés antérieures. Que ce soit pour le sommet que pour le siège. Parce que tout l'homme s'en va vers l'intérieur.

Donc lorsque c'est postérieur, ils font plus de temps pour tourner. Alors que lorsque c'est antérieur, il suffit de tourner 45 degrés pour qu'il devienne au niveau de l'occident, au niveau de la symphyse pubienne. Donc voilà un peu les variétés.

Voilà, on va parler un peu du mécanisme obstétrique. Ce n'est pas quelque chose de très... Marlou, là vous allez avoir une sorte de frustration. Est-ce que vous avez toujours accès à ces cours sonorisés pendant la COVID? Parce que vous êtes là et vous n'avez pas de solution.

Par exemple, en face, j'essaie de mimer, de voir, mais comment faire pour quelqu'un que je ne vois pas? Est-ce qu'il doit entendre le son? Oui ou non? J'ai cherché... J'ai cherché... Malheureusement, j'ai trouvé qu'il y a des sites qui font ça en trois dimensions. Cherchez-les et vous allez les trouver. Est-ce que vous avez accès? Parce que... Bon, je vais chercher si je trouve le lien.

Les liens... Directement. Après, on s'est dit qu'ils étaient confinés, qu'ils n'avaient pas besoin. Mais apparemment, ça a bien marché.

Les résultats étaient bons. Oui. Non, mais non.

Ça veut dire que même l'enseignement à distance... C'était en 2008, 2009. Deux services. Le

service de médecine périnatale de Brest.

Et le service de gynéco-obstétrique de Grenoble. Grenoble, il fait beaucoup plus de la mécanique obstétrique. D'ailleurs, le bouquin que je vous ai lancé, le chef du service... Il est le coordinateur.

Et là, on a fait des DU pour les gynécologues. Des DU, un DU d'échographie fœtale. Et un DU de la mécanique et la technique obstétrique.

Deux DU. Qui font l'enseignement à distance. Mais ils ont... Obligatoirement, ils doivent être présents... Dix matinées.

Pour la pratique. Parce que l'échographie... Tu dois chercher les... Et ça a marché. Pendant deux ou trois ans.

Après, bon... Donc, la mécanique obstétrique... C'est tout le mécanisme qui va aboutir... A l'accouchement du bébé... A la délivrance du placenta... Et des membranes. C'est le mécanisme obstétrique. Chaque présentation a son mécanisme propre à elle.

Dans la présentation du siège... Au début... Lorsque j'étais jeune... Lorsque j'étais jeune... On enseigne... L'accouchement, c'est comme ces... Trois étapes... Séparées. Accouchement du siège... Accouchement des épaules... Accouchement de la tête dernière. Dans le concept actuel de l'obstétrique... Oui, il y a l'accouchement du siège, l'accouchement de l'épaule... Et l'accouchement de la tête dernière.

Mais les trois accouchements... Les trois parties... Sont liées. On ne peut pas... Subdiviser l'accouchement... En un accouchement... De chaque partie. C'est un accouchement.

Je vais vous dire pourquoi. Premièrement... Première condition... C'est que le fœtus... Pourquoi c'est un seul bloc ? C'est un seul accouchement. C'est parce qu'il faut que les membres du fœtus... Pas les membres, les parties du fœtus... Soient solidaires.

Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les pieds doivent être solidaires au tronc... Les membres supérieurs solidaires au tronc... Et la tête est solidaire au tronc. Donc c'est comme ça. C'est un seul bloc.

Cette solidarisation... Entre les différentes parties... Du fœtus... C'est une condition. C'est un accouchement normal. Vous voyez pourquoi je vous ai dit... Au cours de l'accouchement, vous pouvez dire... Stop ! Ça... C'est compliqué.

On va faire une césarienne. Parce que... Dès qu'il y a une désolidarisation... Soit une déflexion de la tête... Soit un relèvement du bras... Ça devient plus facile. Très bien.

Un fœtus... Il y a le siège au niveau de la lune... Mais il va relever ses bras. Il ne peut pas. Il va être emprisonné au niveau de l'étroit supérieur.

Il ne peut pas... Accoucher seul. Soit que tu es un bon obstétricien. Un bon obstétricien.

Un obstétricien expérimenté. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Peut-être.

Je ne sais pas. Qui peut faire des manœuvres... Si tu n'as pas l'expérience... Requête pour faire ces manœuvres... Il vaut mieux faire une césarienne. Sinon tu vas perdre le bébé.

Est-ce que vous avez compris ? Accouchement du siège... Accouchement des épaules... Accouchement de la tête dernière. Ce concept n'est pas valable. Parce qu'on se trouve devant un bloc... Constitué par le tronc... Avec toutes les autres extrémités... Qui sont accolées.

Et si cet accollement n'est pas fait... L'accouchement ne peut pas se faire. C'est ça ce que j'ai dit. Solidarisation de la tête en flexion... Du tronc et des mots.

Tout doit être un bloc. Sinon l'accouchement ne peut pas se faire. Bien sûr... Mais il y a toujours le siège... Qui va accoucher en premier... Parce que le siège va en bas... Après les épaules, après la tête dernière.

Donc le siège... C'est simple. Il y a le siège... Le diamètre du siège c'est quoi ? C'est le triconterien. Les deux triconteres qui mesurent... 95... 9,5... 90... 95 millimètres... 9,5... Le détroit c'est 12... 12,5... Il va s'orienter... En général c'est comme dans la présentation... Du sommet... Il va se présenter vers... Le détroit le plus grand.

C'est pour ça que... La sacroiliègue gauche antérieure... C'est la plus fréquente. C'est parce que... Toujours le bébé va s'orienter... En général c'est pas le bébé... C'est les autres... Il y a les releveurs de l'anus... Il y a les tendons... Il y a beaucoup de choses qui font que... Il y a le travail de l'utérus... C'est une pompe... Qui contracte... Qui va s'orienter... Le plus grand diamètre de la présentation... Au plus grand diamètre... Du détroit supérieur... Ici le plus grand diamètre... C'est le vitreum compérien... 9,5 cm... Le diamètre oblique gauche... Est le plus grand... 12,5 cm... 3 cm de différence... Il va passer sans aucun problème... Il va passer... Lorsqu'il passe... Le détroit supérieur... Il va trouver l'excavation... Donc là... Sous l'effet toujours de la contraction... Il va faire une rotation... Une descente... Une rotation... Cette rotation qui va ramener... Le vitreum compérien... En entero postérieur... Un sous la symphyse pubienne... L'autre trochanter au niveau du sacrum... C'est ça... C'est le sacro pubien... Le entero postérieur... Du détroit inférieur... Il est au niveau du détroit inférieur... Comme ça... Il y a toujours la contraction... En ce moment... Le bébé doit faire une rotation... Je parle du bébé en siège... Ça c'est une obligation... Il doit tourner le dos en avant... Je vais vous expliquer pourquoi... Donc... Une fois la hanche... Juste parce que c'est la même chose... La hanche il y a le trochanter... En antérieur au niveau de... De la symphyse pubienne... L'autre au niveau de... Du sacrum... Donc il va sortir... En ce moment... Toi tu ne dois rien faire... Il ne faut même pas toucher le bébé... Parce que tu vas le chatouiller... C'est un être vivant... Donc il ne faut pas toucher... Tu es là, tu es en train de voir... Et à n'importe quel moment... Tu vas intervenir... Mais tant que tout se fait bien... C'est pas la

peine... Donc le siège il est sorti... Parce que c'est très petit... C'est mou... Tu n'as pas de problème... C'est pas comme la tête... Il faut l'aider pour qu'elle fasse son dégagement... Une fois le siège sorti... Il va faire une rotation du dos en avant... C'est une condition... S'il ne fait pas ça... Si tu vois qu'il est en train de faire la rotation en arrière... Ou là il tarde à faire sa rotation en avant... Là... Il faut intervenir... Donc ici... La rotation du dos... Doit se faire en avant... Il y a deux conditions... La première condition... C'est la solidarisation de la tête, le tronc et les membres... Deuxièmement... Après le dégagement des hanches... Du siège... Le dos doit tourner en avant... Est-ce que vous avez retenu ça ? Est-ce que vous avez compris ? Difficile... Oui, je sais... C'est comme ça... C'est le siège... Donc le siège... On est là... Toujours... Il doit rester comme ça... Il est comme ça... Et il tourne... Pour que... Quel est le diamètre... Entre les épaules... Le diamètre... Bi-acromial... Donc... Au cours de la rotation du dos en avant... Tout le bébé tourne... Pas uniquement le dos... Même les épaules... Donc il est en train de chercher... Là où il doit... S'engager... Au niveau du détroit supérieur... Il s'engage... Dans le même plan... Dans le même diamètre... Du détroit supérieur... C'est-à-dire... L'oblique gauche... Le bi-acromial va prendre... L'oblique gauche... S'il prend l'oblique droit... Parce qu'ils sont dans le même plan... Vous voyez... Par contre, lorsque je vais arriver à la tête... C'est l'inverse... C'est le plan perpendiculaire... Regardez le plan... Dans l'espace... Donc c'est perpendiculaire... Donc les épaules... S'engagent dans un diamètre oblique... En général le même diamètre que... Le bi-trochanterien... Il va parcourir l'excavation... Et vous allez voir... Qu'il est là... D'abord l'épaule antérieure... Parce qu'il est sous la synthèse pubienne... Il va glisser... Et puis l'épaule postérieure... Ici, ça ne se passe pas toujours... Rapidement... Parfois il faut agir pour... Libérer les membres supérieurs... Surtout le bras... On verra ça... Et après, la tête... Il est toujours solidaire... S'il fait ça, l'accouchement ne peut pas se faire seul... Il doit être... Il doit être... Le montant... Doit être... Au contact du sternum... Il doit... Pourquoi la rotation... Doit se faire du dos en avant ? C'est surtout... Pour que l'occiput... Soit en avant... Parce que si l'occiput tourne en arrière... Le montant... Va s'accrocher à la synthèse pubienne... En haut... Il y a ça, la synthèse pubienne... Si le dos ne tourne pas en avant... Il est en arrière... Le montant va... S'accrocher à la synthèse pubienne... Il ne peut plus accoucher... La femme ne peut plus accoucher seule... Jamais... C'est pour ça que le dos tourne en avant... C'est l'occiput qui est... Au niveau de la synthèse pubienne... Et le montant il est en arrière... Donc il n'a pas... Mieux de s'accrocher... Il n'y a que l'excavation après... Donc là... L'occiput va être... Doit être en avant... Au début... L'occiput... Va chercher l'oblique... Qui est... L'oblique perpendiculaire à l'oblique... Qui a été emprunté... Par le bitrochanterien et le biachromien... Je vous ai dit que... Le plan de l'occiput est... Perpendiculaire au plan... De biachromien... Donc il va chercher... Il va... Il va passer parce que... C'est le sous-occipito... Bragmatique... C'est 9,5 cm... Donc ça va passer sans aucun problème... Puis il y a la rotation... Du dos en avant qui va ramener... L'occiput... Au niveau de la synthèse puvienne... Et le montant en arrière... Après, le dégagement se fait... Comme ça... Seul, sans aucun problème... Je vais vous montrer avec les photos... Je pense que ça va être... Qu'est-ce que j'ai pas... C'est ça... Le montant au niveau du périnée... Et l'occiput au niveau de la synthèse puvienne... Ils ne vont pas s'accrocher... Il n'y a pas lieu de l'accrochage... C'est le mal accrochage du montant en avant...

C'est pour ça qu'il faut éviter... De faire le... Voilà... Ça c'est le siège... Il est là... Au niveau de la bulle... Vous n'êtes pas obligé de faire... L'épiziotomie... Sauf, bien sûr, chez la primipare... Ou bien... Lorsque c'est une multipare, c'est pas la peine... Lorsque c'est une primipare, et la impérinée est tendue... Il vaut mieux faire l'épiziotomie... Parce que l'épiziotomie... Empêche les déchirures... Les autres déchirures... Et surtout les déchirures qui vont... Vers l'intestin... L'anus et le canal anal... Ça c'est le sphincter... Par contre, lorsqu'on fait un dit... C'est la médiolatérale... Ça s'appelle la médiolatérale... Il y a qui se fait comme ça... C'est la latérale... Il y a qui se fait comme ça... C'est la médiane... Qui est faite par les américains... Parce qu'elle est... Plus anatomique... Mais il y a le risque d'atteinte du sphincter... Celle-là évite l'atteinte du sphincter... Voilà l'épiziotomie... Voilà ce que je vous ai dit... Ça c'est la hanche antérieure... Ça c'est la hanche postérieure... Ça c'est la symphyse pubienne... Elle est là... Ici c'est le sacrum... Donc il y a l'accouchement qui va se faire... Sans aucun problème... Parfois tu peux aider... Voilà les deux membres... Les deux fesses qui sont à l'extérieur... Ça c'est le dégagement... Voilà... Je vous ai dit qu'il y a la rotation du dos en avant... Vous voyez... C'est obligatoire... Parfois, surtout dans le siège décomplété... Les membres inférieurs... Ont du mal à sortir... Donc tu peux introduire les mains... Pour faire sortir les deux pieds... Les deux membres inférieurs plutôt... Donc voilà... Tu fais sortir le premier... Tu fais sortir le deuxième... Et là tu vois qu'il est en train de dégager... Les épaules... Une épaule antérieure qui va sortir... Puis une épaule postérieure... Voilà l'épaule antérieure qui est sortie... Tu vas l'aider... Tu vas aider les bras... Pour sortir... Bras antérieurs... Puis bras postérieurs... Et voilà... Là, tu as la tête... Qui est au niveau du périnée... Au niveau de la vulve... Tu fais ce mouvement... De déflexion... Pour faciliter... C'est pas le détroit supérieur... Ça c'est au niveau de la vulve... Donc tu fais ça... C'est la manœuvre de Bracht... Que vous faites... Et vous aurez votre accouchement... Le voilà, l'enfant qui va sortir... Donc vous voyez que... Le menton n'est pas en avant... Parce que s'il est en avant... Il ne va pas accoucher normalement... Le dos doit tourner en avant... Parce que s'il ne tourne pas en avant... C'est le menton qui va tourner en avant... Ainsi de suite, tout est lié... Donc voilà, les complications sont fréquentes... La mortalité est fréquente... En fonction... Vous allez voir... 0,7 à 3... 7%... C'est en fonction... Si tu fais... Toutes les femmes qui ont un siège... Tu leur fais une césarienne... Tu n'auras pas de problème... Sinon tu as des problèmes... Il y a l'asphyxie du postpartum... Il y a les malformations sévères... Parce qu'on dit que... Les malformations... Donnent le siège... C'est une étiologie... Beaucoup plus le siège... Qu'une complication... Il est malformé, il va mourir... Il y a la mort totale immunitaire... Il y a le traumatisme obstétrique... C'est très fréquent... Il faut faire attention... Il y a les complications immédiates... Qui vont disparaître par la suite... La première des choses... C'est les déformations plastiques... La dolicocephalie, l'aplasie maxillaire... Parce que l'enfant... Pendant longtemps il est comme ça... Une aplasie maxillaire, une dolicocephalie... Une torticolie congénitale... Et surtout... L'aplasie du côté... C'est très fréquent... La luxation congénitale de la hanche... C'est plus fréquent dans l'accouchement... Chez l'enfant né par siège... De sexe féminin... Donc voilà, c'est ça... Les pieds beaux, virus inquit... Virus albus, etc... Il y a les autres complications... Qui sont traumatiques... Le traumatisme obstétrique... Les hémorragies cérébrales mélangées... C'est plus fréquent... Parce que c'est une pression qui se

fait... De bas en haut... Vers la tête... C'est pour ça que les hémorragies sont très fréquentes... Les atteintes de plexus brachial... Ils ne savent rien... Ils savent pas... Lorsqu'ils voient le siège et tout... Ils commencent à tirer sur le siège... Ce qui va entraîner des lésions... De plexus brachial... Les fractures... Ce n'est pas grave... J'en ai fait quelques-unes... Moi aussi... C'est très fragile... Le fait d'aller chercher... Avec le doigt... Tu peux le fracturer... Mais les fractures de bébé... Ce n'est pas grave... Les lésions musculaires... Les lésions de l'appareil génital... Surtout... Le sexe masculin... Parce que là... Les testicules en bas... On fait beaucoup de toucher... On peut entraîner des lésions à ce niveau... Il faut faire attention... Le retard scolaire... Devenir lointain... Les troubles de mémoire... Beaucoup d'études ont fait... Maintenant... Trouver qu'un enfant... Né par siège... Est le même qu'un enfant... Qui n'est pas né par le siège... Ce n'est pas ça... Quelle est votre conduite obstétrique ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Premièrement... Je vous ai dit que... Avant 34-35 semaines... On ne parle pas de présentation... On parle de siège en bas... Parce qu'on ne sait pas... Il peut tourner par la suite... Ne parlez pas de la présentation... 36-37 semaines... Vous faites le diagnostic... Donc... Vous allez chercher... Quels sont les facteurs pronostiques... Du siège ? En général... On va chercher... Les facteurs pronostiques... Il y a les facteurs... Pronostiques... Les facteurs absolus... De mauvais pronostic... Il y a les facteurs... Relatifs de mauvais pronostic... Lorsqu'il y a un facteur... Absolu de mauvais pronostic... C'est un césarien... Systématique... Lorsqu'il y a beaucoup de facteurs... Relatifs de mauvais pronostic... Tu vas mettre une balance... Les facteurs de bon pronostic... Les facteurs de mauvais pronostic... Et si ça penche vers le mauvais pronostic... Vous faites un césarien... Si ça penche vers le bon pronostic... Vous laissez la forme affichée... S'ils sont égaux... Vous laissez la forme affichée... Et après vous allez voir... Donc... Les facteurs plutôt... Sont le mode de présentation... C'est un facteur relatif... La présentation décomplétée... Est meilleure que la présentation complète... Parce que la présentation décomplétée... Est irrégulière... Par contre la présentation complète... Il y a les pieds qui sont irréguliers... Et par conséquent... Il ne sollicite pas bien... Le segment inférieur... La gestationnaire... La prématurité... Les portrophies... Ce sont des facteurs de mauvais pronostic... Il est déjà vulnérable... Ajouter à ça... Le traumatisme obstétrique... Ça va être plus grave... Il y a la biométrie fœtale... C'est important... Le siège... Tu ne peux pas laisser... Si tu fais l'estimation de poids de 4 kg... C'est une césarienne... Donc on ne doit pas... Laisser une femme... Qui a une présentation du siège... Accoucher un macrosome... Par voie naturelle... Donc ça c'est le poids... La biométrie fœtale... La position de la tête dernière... Je vous ai dit que tout doit être solidaire... Donc la tête doit être bien pliée... Une déflexion de la tête... Ça s'appelle déflexion primitive... De la tête dernière... C'est une indication à la césarienne... C'est un facteur absolu... De mauvais pronostic... Ça c'est les facteurs... Les facteurs maternels... C'est un peu... Bon... À part le bassin... Le reste c'est subjectif... Un bassin anormal... Quel que soit le cas... C'est pas comme la présentation du sommet... Un bassin anormal... Est une indication de la césarienne... Et il y a l'âge... La parité... La qualité de l'utérus... La taille... Le poids... Ça en général c'est des facteurs relatifs... Bon vous allez les faire entrer dans la balance... Mais qui vont peser pour... L'indication... La parité... Oui ça joue... Si tu as une femme de 40 ans... Qui vient de tomber enceinte... Pour la première fois... Elle est en siège... Peut-être c'est la dernière chance...

Donc vous voyez... Il y a la subjectivité là-dessus... Parce qu'on est des êtres humains... Tu es devant une femme... Un bébé... Et il y a la souffrance fœtale chronique... Il y a l'infertilité... Tout ça entre en jeu... Pour... Décider... Ou non... De laisser la femme accoucher par voie basse... Les césariens prophylactiques... Qu'est-ce que c'est une césarienne prophylactique ? Une césarienne prophylactique... C'est une césarienne qui se fait en dehors du travail... C'est-à-dire en général... Aux alentours de 39 semaines... On ne laisse pas la femme jusqu'en travail... C'est une césarienne prophylactique... Ou bien césarienne programmée... Les deux... Césarienne prophylactique... C'est une femme de 39 semaines... Dame énorée en général... Deuxièmement, c'est une femme... Qui doit faire sa consultation pré-anesthésique... Parce que... Tu as le temps de faire la césarienne... C'est une césarienne... Qui doit se faire pas la nuit... Elle doit être programmée... Le matin... Comme une intervention chirurgicale... Elle ne doit pas être faite par l'équipe de garde... Parce que l'équipe de garde... En général est fatiguée... Donc elle doit être faite le matin... À jeun... Avec une équipe qui n'est pas de garde... Avec une consultation pré-anesthésique... Et la femme doit être à jeun... C'est la césarienne prophylactique... Une césarienne prophylactique... Est plus sûre qu'une césarienne en urgence... Une césarienne en urgence... Il y a des complications... Donc... Quand est-ce qu'on doit faire ? Il y a les indications formelles... C'est-à-dire... Il faut faire une césarienne... Premièrement, les anomalies du bassin... Quelle que soit l'anomalie du bassin... Il faut faire une césarienne... Deuxièmement, la déflexion primitive de la tête... Apparemment... Ce n'est pas uniquement... J'ai vu une publication... Ce n'est pas uniquement... Parce que l'accouchement ne peut pas se faire... Même si tu peux faire l'accouchement... Il faut l'éviter... Il y a la section de la moelle épinière... Au niveau cervical... Tu exagères... Et tu entraînes la rupture de la moelle... Et c'est la paraplégie... Il y a ça également... Il y a beaucoup de cas... D'enfants qui sont nés... Comme ça... Donc déflexion primitive de la tête... C'est une césarienne... Placenta previa... Lorsqu'il est recouvrant... C'est une césarienne... Et le périnée cicatriciel... Parce que tu es amené à faire beaucoup de manœuvres... Ça en général... Il faut un périnée qui est souple... Si c'est un périnée cicatriciel... Tu vas faire éclater le périnée... La fibrose... C'est plus simple à lâcher... Il y a les indications relatives... Vous mettez une balance et vous voyez... Il y a l'utérus cicatriciel... Monocicatriciel... Si c'est deux cicatrices, il faut l'opérer... Mais si c'est une seule cicatrice... Actuellement, on peut laisser évoluer... La grande prématurée... C'est en fonction du plateau technique... Si j'ai une grande prématurée... Un grand prématuré de 24 semaines... En siège... Et je sais que j'ai un service de neonat... Qui ne peut pas le prendre en charge... Bon, c'est pas la peine de faire la césarienne... Ça ne sert à rien... Mais si tu as un plateau technique neonatal... Qui permet la survie des enfants... De moins de 24 semaines... 26 semaines... C'est bon, tu fais la césarienne... La primiparagée... Les antécédents d'infertilité... Les antécédents de dystocie... Ça, en général, on discute... Vous voyez le pour et le contre... La version par manœuvre externe... C'est une version qui n'a pas de sens... L'équipe de Grenoble... Et c'est dingue... La version s'est donnée... Des murs relaxants pour l'utérus... La progestérone naturelle, etc... Ou la loxène, etc... Pour éviter l'accouchement prématuré... Et essayer de faire tourner... Le bébé par l'extérieur... De telle sorte que le siège... Devient en haut et la tête en bas... Ça prend beaucoup de temps... La version par manœuvre...

Externe... Ça va retentir... Sur le taux de césarienne... Je trouve que c'était... Aberrant de faire ça... Il y a beaucoup de complications... Sur le taux d'accouchement prématuré... L'hématome rétro-placentaire... Et la souffrance fœtale... C'est pour ça que... Ça ne se fait plus... Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez donc... Soit que c'est une césarienne... Il y a la césarienne prophylactique... La surveillance du travail... La phase de dilatation... L'évolution doit être harmonieuse... Avant dilatation, bon siège... Si la dilatation est harmonieuse... Le siège est bon, elle peut accoucher... Respecter la poche des os... Si elle n'est pas rompue... S'il y a une hypocynésie... Vous pouvez donner des os cytotocycliques... Vous pouvez faire la péridurale... Actuellement, tout le monde fait la péridurale... La phase d'expulsion... La dilatation est complète... Le siège est engagé... Dans ce cas... Vous rompez la poche des os... Vous donnez des os cytotocycliques... S'ils ne sont pas donnés avant... Et il faut surveiller... Le RCR... Après, entre l'engagement... Et l'accouchement... Ça ne doit pas... Dépasser les 30 minutes... Parce que c'est un temps où l'enfant... Est sous contraction utérine... En permanence... Il va souffrir... Donc 30 minutes... Au-delà de 30... Faites une épisiotomie... Si vous voyez qu'il y a... Une distanciation importante... Du périnée... Et puis, en cas de complication... Il faut intervenir... Intervenir comment ? Les manœuvres oscétricales du siège... Il faut avoir de l'expérience... Pour les faire... L'enfant est comme ça... Le siège est là... Mais la revêtement... Vous allez introduire... Votre bras... Pour aller chercher le pénurie... Tu vas prendre... Le pénurie en matèse... Le numérisme... Tu vas prendre le numérisme en matèse... Et tu vas lui faire descendre... Une fois que tu le descends... Tu vas faire... Il y a l'épaule antérieure... L'épaule antérieure... En fait... C'est pas quand on va... En postérieure, il y a l'excavation... Qui permet... De faire pénétrer le bras... Et tu fais une rotation... Pour que l'épaule antérieure... Devienne postérieure... Et tu fais le même geste... Et tu vas descendre les deux... Mais une règle... L'approchement du siège... C'est que... Lorsque tu commences... Tu commences l'intervenant... Tu dois le terminer... C'est-à-dire lorsque tu fais... La descente des deux bras... Tu dois terminer pour descendre la tête... Donc ça c'est le relevement des bras... Tu fais... Il y a la manœuvre de l'offset... C'est quelqu'un qui s'appelle l'offset... Et qui a... C'est... Donc... Le bras... Le bras... Le droitier... Il doit pénétrer le bras en postérieure... Pas en antérieure... En antérieure il ne va pas passer... Parce qu'en postérieure... Il fait une rotation pour l'offset... C'est-à-dire... La rétention de la tête... Il y a deux types de rétention... Il y a la rétention de l'horizontale... En bas... Ça c'est une rétention qui est simple... Tu prends le bébé... Tu vas mettre le dos du bébé sur le ventre de sa maman... Ça va déplacer la tête et le ventre... Mais... Là il y a une manœuvre qui s'appelle la manœuvre du bras... Du bras... C'est une manœuvre... Il y a le bras... Mais ça donne beaucoup de résultats... La manœuvre du bras... Sans compliqués... Parce que l'enfant est déjà né... On dirait... On dirait que la bouche... C'est comme ça... Comme ça... La bouche est à l'extérieur... Il y a l'effet de pression... L'inhalation... Il y a la manœuvre du devant du seau... Là on est dans le sérieux... La manœuvre du devant du seau... C'est là où la tête dernière... Est bloquée... Au-dessus du décroix supérieur... Là... Tu dois faire entrer... Il y a le dos qui est en avant... Le ventre qui est en arrière... Tu vas glisser ta main... Le long du front... Jusqu'au niveau de la bouche... Tu vas introduire les deux doigts au niveau de la bouche... Et tu vas prendre appui... Au niveau du



maxillaire... Pas au niveau de la glotte... Au niveau du maxillaire... Là c'est un plan osseux... Et tu dois... Essayer de faire la flexion de la tête... Qui est en train de faire ça... Pour ramener le montant de l'œil... En même temps... Tu fais glisser ta main en latérale... Puis en avant... Pour prendre ici... Donc ici... Là... Et tu es en train de voir... Qui est le plan... Le décroix supérieur... Le plan du décroix supérieur le plus large... Où tu peux descendre... Lorsque tu peux descendre... Tu fais tourner le montant en arrière... L'obstétrique en avant... Et tu fais sortir... Là... Là c'est la manœuvre de Mauricio... C'est pour ça que... À part la manœuvre de bras... Qui est plus simple... Les autres manœuvres... Nécessitent de l'expérience... C'est pour ça que les gens... Apparemment... Les manœuvres obstétriques... Elles vont disparaître... Le forceps de Tarnier... Maintenant personne ne travaille... Avec le forceps de Tarnier... Les manœuvres obstétriques... Personne ne fait les manœuvres obstétriques... Et ça c'est pas bien... Donc il y a la petite extraction du siège... La grande extraction du siège... La petite extraction du siège... L'enfant est né... Jusqu'au niveau des poids de thermoplates... Et l'accouchement est plus simple... Il ne faut ni descendre... Ni appuyer... Donc là... Tu vas faire descendre... Tu prends appui... Tu vas descendre... Tu vas faire une rotation en avant... Si... Un bras est dégagé... C'est bon, tu fais la rotation de l'autre... Si le bras n'est pas dégagé... Tu fais comme le l'autre... Tu fais descendre le bras... Et tu termines par le moriceau... Donc... Tu dois compléter... Petite extraction du siège... Tu dois faire... L'accouchement des épaules... Et tu dois faire... L'accouchement de la tête... Manuel dit... La grande extraction du siège... Ne se fait actuellement que... Lorsqu'il y a un deuxième... Du mot... C'est le deuxième du mot... En haut... En présentation de siège... C'est là... La grande extraction du siège... Où l'accouchement est fait... Par l'océanique... Et tu fais descendre les bras... Et la tête... C'est toutes les étapes de l'accouchement... Qui le font... Bien sûr... Entre les mains expérimentées... Pour ceux qui touchent... A un accouchement de siège... Qui augmente le risque de complication... De 1 à 25%... C'est énorme... Pour le même... C'est à dire... J'ai pas touché... L'autre groupe... J'ai touché... 1 à 25% de plus de complications... Ça veut dire... Que ça ne dépend pas de compétence... Ça dépend... Des circonstances... De l'accouchement... Et c'est pour ça... Que les gens... Sont plus de ces arènes... C'est pas par hasard... Il faut chercher la petite bête... Un cheveu... Qui est mal peigné... Ces arènes... Cherchez quelque chose... Pour faire la césarine... Parce que... Il y a beaucoup de complications... Voilà... Il y a des remarques... Des questions... Rien... Je n'avais rien dit... Donc... Si vous pouvez... La réaction... Vous pouvez... Réagir... C'est tout... C'est tout... Merci...